《药品说明书中涉及老年人群用药信息的撰写要点

（征求意见稿）》

征求意见反馈表

单位/企业名称填写人	上海交大附中 IB 课程中心，高一学生 向容融			
联系电话 电子邮箱	13917245279 xiang.rongrong.24@jdfzib.org			
序号	**修订的位置（页码和行数）**	**修订的内容（原文）**	**修订的建议**	**理由或依据**
1	第 3 页第 57-59 行 第 5 页第 91-99 行	警示语 禁忌	建议处方药都增加表述以专业医生处方医嘱为准， 如果是非处方药，才需要写得直接清楚些。 建议在药品说明书中加入粗体、颜色等突出标记的办法，特别是提醒事项适用的前提，比如“过敏者”加粗。	老年人服用的药品一般为处方药，都同时有医生处方医嘱，老人疾病相对复杂，如果医嘱与说明书不完全一致，会导致老人更加谨慎不敢服药不知如何服药，反而容易造成用药依从性降低。 根据普通人的阅读习惯，在阅读长篇资料的时候会先扫读一遍，对于有特别标记的地方，更容易关注。禁忌或警示情况一般都有前提，把前提标粗或突出，能更好的帮助老年人避免误解和依从性下降。比如老人第一眼看到的是“禁忌”“不良反应”与第一眼看到的是“过敏者需注意”，应该完全是不同的。 毕竟患者适不适合能不能用这个药，是医生处方决定的，而不是药品说明书，患者版药品说明书要解决的是患者对医生对药品的信任和理解，是用药过程中依从性和安全性问题。
2	第 4 页第 69-79 行	用法用量	给老人看的药品说明书应更有操作性，给出通俗具体的服药方式、可能遇到的各种问题，尽可能通俗表达，比如用问答形式	药品说明书通常已经很长，如果再增加这么多复杂的方案，老人未必看得懂，而说明书更长更厚药企成本更高，也更没人看药品说明书。 在国外就有区分专业药品说明书和患者说明书，用于给患者看的说明书主要是把怎么用药、怎么储存药品说清楚，以及把药品的作用让患者信服，提高用药安全性和依从性。医疗上的专业方案和选择，应该是给医生看的。
3	第 4 页第 81-89 行	不良反应	建议适当减少专业术语，只	愿意仔细看药品说明书的老人通常更谨慎，不良反应的描述越多越可怕，会让患者在服药时依从

			把常见的问题出现时，应该怎么看待和紧急处理说清楚，如某些药品的不良反应是正常现象则需要重点说明，帮助老年患者识别和处理不良反应。	性更差。 比如我外公，医生最近给他开了药，可是他看到药品说明书上有那么多严重的不良反应后，就表示担心不想吃了。老人总说：“不怕一万，只怕万一。”他们是一个看待事物十分谨慎的群体，“可能”两字在他们眼中可能就是“一定”。 药品说明书不应该是药企和医生摆脱医疗责任的文书，那些应该在药品上市和管理、医生处方和专业学习资料上体现。对于患者特别是老年患者，应该少写。
4	第 6 页第 123-124 行	注意事项	建议增加图文及药品原理的说明。建议与用法用量和晋级写在一起，方便查看。	注意事项这里看起来都是提醒事项，要提高老年患者的服药依从性，应该需要更多内容。
5	第 9 页 135 行-第 10 页 167 行	药物相互作用 药品过量 临床药理 临床试验	建议 1：将相互作用与过量统一归为注意事项，且将相互作用部分的内容改为类似“服用本药品时不能与其他什么药与食品同时服用？”这种 Q/A 问答形式。 建议 2：如果是面向患者的药品说明书，建议删除临床药理和试验部分。	药品说明书作为一个设计，跟其他物品说明书类似，需要能够与患者用户沟通，让患者理解并更好的使用药品。老年人查看药品说明书最需要看的是如何安全使用药品。 临床药理和临床试验部分也许可以让患者对该药品的效果与来历更加信任，但这对于没什么专业知识特别是认知能力一般的老人，也许并没什么用，还额外增加页面字数，可能让说明书更密密麻麻更厚，药企也要抱怨增加成本。 患者特别是老年患者，通常将医生看作权威，医生有处方权对患者用药的安全性负责，患者需要的是相信医生，有好的用药依从性，而不是去了解太多他们没法完全理解的专业知识。 事实上，现在很多老年人对医生的信任度很低，药品说明书作为一个医患沟通的桥梁，应该可以做得更好。 比如其实可以参考国外做法，做成两个版本。一是专业版，阅读对象是专业医生和药师，说明完整药理、不良反应和临床试验数据等等，另一个是患者版，阅读对象是患者，注重用药方法及可能出现的问题的处理方法，而且要更简单，通俗。患者真正需要的是：用药关键点（何时吃、吃多少）、安全警示（哪些情况不能吃、副作用应对）、以及特殊人群注意事项。那些化学式、药代动力学数据对普通患者并不必要。